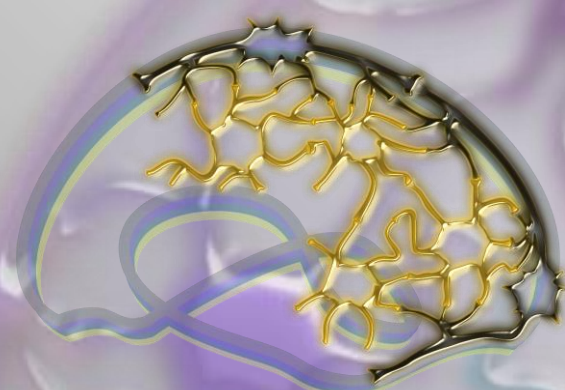




IN&S

Instituto para las Neurociencias & la Salud

María Cristina Pinto - Ps. M.Sc Neurociencias

Dirección Clínica IN&S

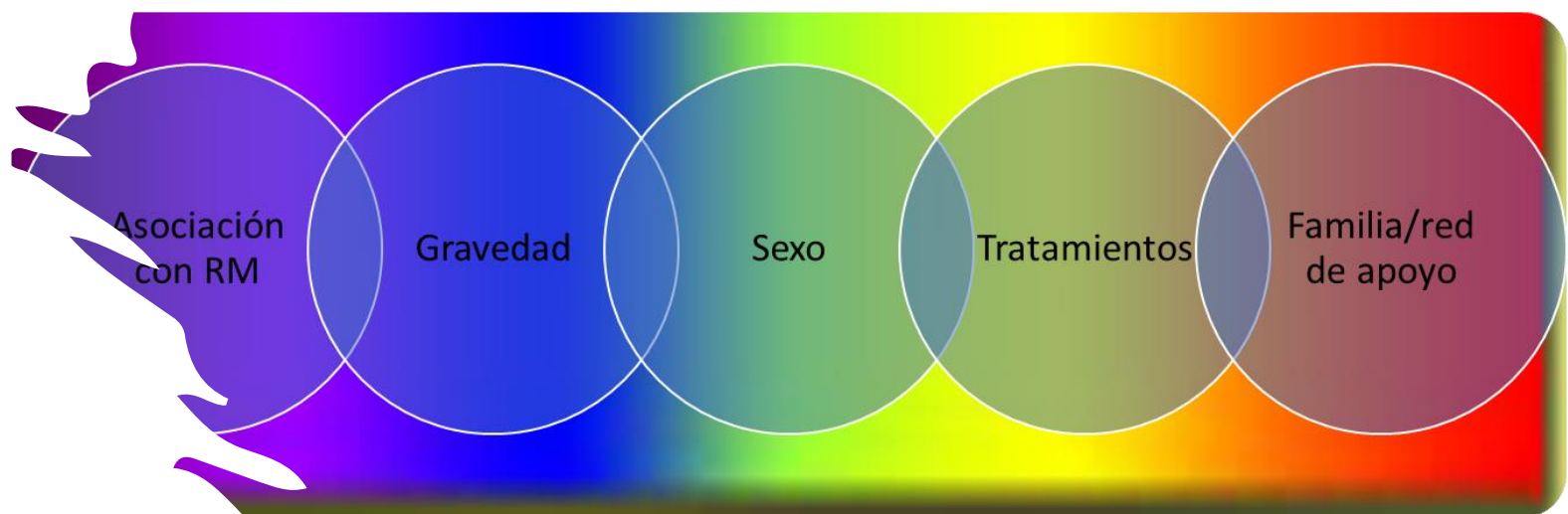
03/04/2024

[IN&S](#)



Trastornos del Espectro Autista

- Trastornos Neuropsiquiátricos/neurodesarrollo.
- Etiología desconocida-multifactoriales
- Heterogeneidad clínica
- Diferencias en la reciprocidad socio-emocional y la presencia de comportamientos e intereses restringidos/repetitivos.
- Lenguaje atípico



Etiología



Genético:
probabilidad ~20 %
en familiares de
TEA.



Endofenotipo:
Lenguaje atípico.



Cada vez más
considerado por
alteraciones en la
circuitería neuronal
que emerge
temprano, incluso
antes del 1 año de
vida postnatal.



Organización
atípica de la
sustancia blanca
(SB), que se
evidencia en los
tractos de fibras
que atraviesan el
cerebro.



P.e. la cognición
social y control del
comportamiento se
han relacionado
con las vías intere
intrafrontales de la
SB en niños
pequeños con TEA .



Conductas
repetitivas e
intereses
sensoriales a los
dos años se han
asociado con SB FA
(Anisotropia
Fraccional) en las
vías del genu y
cerebelosa a los 6
meses de edad

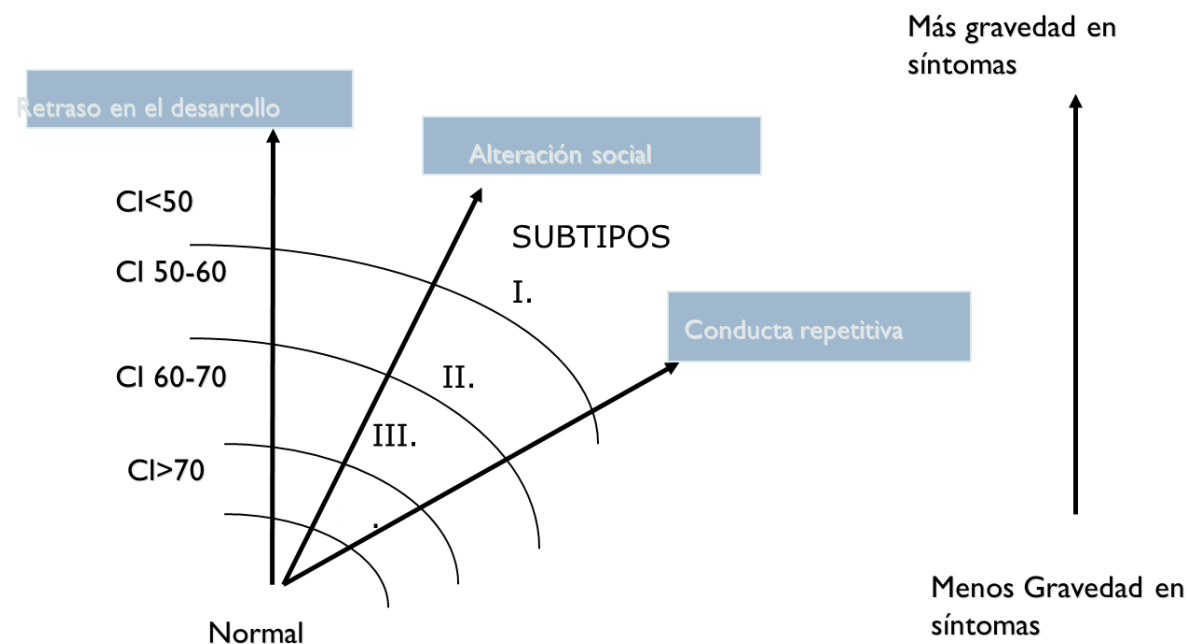
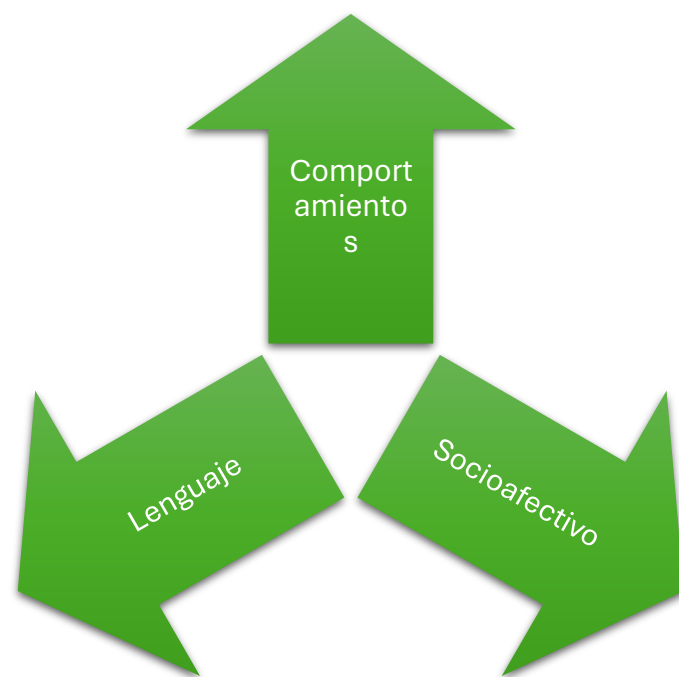


WM FA in the
superior
longitudinal
fasciculus and
splenium of the
corpus callosum
have been linked to
autism trait severity
from ages 2.5 to 7
years –



Se sugiere que el
fascículo arqueado
puede tener una
relación específica
en el desarrollo
del lenguaje
expresivo en el
curso de un año de
vida que reciben
diagnóstico a los 2
años. McFayden et
al. 2024

Tríada de Wing y Gould (1979) – DSM IV-TR



 DSM IV- TR, La definición diagnóstica del autismo en el DSM-IV se caracterizaba por 3 síntomas de base (tríada):

 a. Deficiencias en la reciprocidad social

 b. Deficiencias en el lenguaje o en la comunicación

 c. Repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo.

 DSM-V, sólo quedan dos categorías de síntomas:

 a. “Deficiencias en la comunicación social” (los problemas sociales y de comunicación se combinan)

 b. “Comportamientos restringidos y repetitivos”.

 Las categorías recogen los mismos elementos que en el DSM-IV, a excepción de dos cambios importantes:

 a. Las “deficiencias o retraso en el lenguaje” ya no se incluyen en esta categoría de síntomas del DSM-5.

 b. El síntoma clínico “sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales”, que no aparecía en el DSM-IV, se incorpora ahora a la categoría “comportamientos repetitivos”.

 Uso de especificadores:

Clínicamente

- Patrón del desarrollo (Discapacidad intelectual, Tx. Del neurodesarrollo)
- Lenguaje y habilidades comunicativas (Vs. Disfasias)
- Procesos sensoriales (Vs. Trastornos desintegrativos. Tx. Coordinación motora).
- Comportamiento/emociones (Vs. Tx. De ansiedad –mutismo selectivo- Tx. De conducta – TDAH- TOC, etc.)
- Habilidades cognitivas

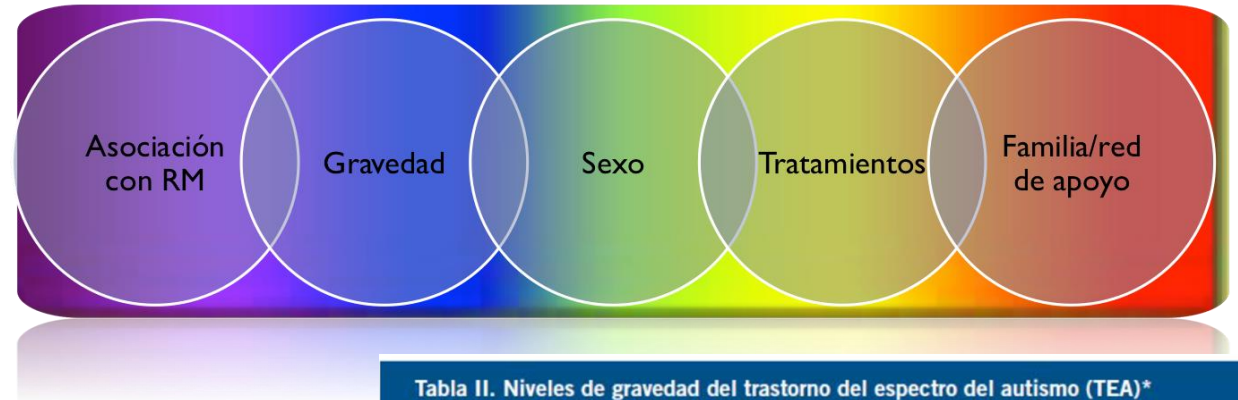


Tabla II. Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo (TEA)*

<i>Categoría dimensional del TEA en el DSM5</i>	<i>Comunicación social</i>	<i>Comportamientos restringidos y repetitivos</i>
Grado 3 "Necesita ayuda muy notable"	Mínima comunicación social	Marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultades de cambio y foco atención
Grado 2 "Necesita ayuda notable"	Marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas	Interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco
Grado 1 "Necesita ayuda"	Sin apoyo <i>in situ</i> , aunque presenta alteraciones significativas en el área de la comunicación social	Interferencia significativa en, al menos, un contexto
Síntomas subclínicos	Algunos síntomas en este o ambas dimensiones, pero sin alteraciones significativas	Presenta un inusual o excesivo interés, pero no interfiere
Dentro de la normalidad	Puede ser peculiar o aislado, pero sin interferencia	No interferencia

*Fuente: American Psychiatric Association, 2014.

¡El síntoma no hace el dx!

Lenguaje

-  Características “atípicas”
-  No conducta protodeclarativa o protoimperativas
-  No hay lenguaje verbal y no seguimiento instruccional
-  Estereotipado
-  Tercera persona
-  Alteraciones pragmáticas y prosódicas: Literalidad.
-  Habla adultomorfa
-  Pobre intención comunicativa.

Social

- 🧠 Limitado interés en el otro/Incluso con la madre-Vínculo frío
- 🧠 No contacto visual o uso de la mirada.
- 🧠 Aislamiento social
- 🧠 Sordera paradójica. No respuesta al llamado o nombre.
- 🧠 No juego simbólico o cooperativo o es forzado.
- 🧠 Juego paralelo
- 🧠 Interés por las cosas no por las personas.
- 🧠 Uso instrumental de las personas
- 🧠 Inteligencia práctica

Comportamiento

-  Estereotipado
-  Tendencia a la monotonía: Rígido, Repetitivo/Ritualizado
-  Apego o hiperfoco en ciertas actividades.
-  Intereses restringidos. Uso repetitivo o rutinario.
-  Dificultad de adaptación al cambio u Oposición al cambio en el entorno.
-  Preferencia por patrones (alineación, clasificación)

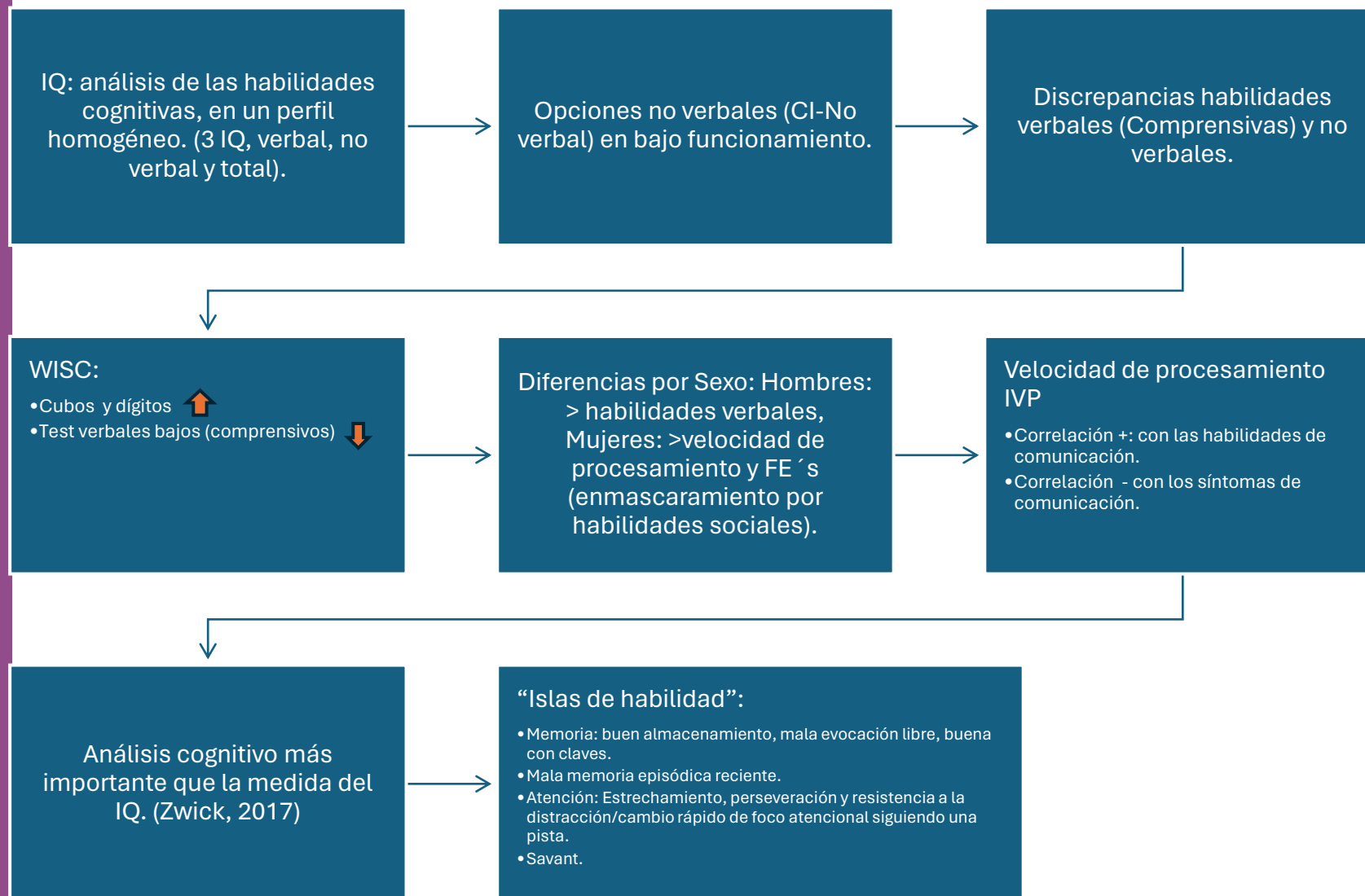
Sensorial/motor

-  Hiper o hiposensibilidad
-  Estereotipias o acciones repetitivas/autoestimulantes.
-  Caminar en puntas
-  Umbral del dolor alto o particular.
-  Selectividad alimentaria, olfatoria
-  Hipersensibilidad táctil (ropa, textura) y auditiva (ruidos fuertes, gritos). Rechazo al contacto físico.
-  Torpeza motora, mejor gruesa que fina.
-  Formas diferentes de aproximarse a los estímulos. “Foco en el árbol no en el bosque”.

Emocional

-  Fallas en la identificación y comunicación de estados internos o necesidades: “adivinar”.
-  Fallas en el reconocimiento de emocionales propio y en los demás.
-  “Meltdown” y “Shutdown”: exteriorización o internalización de una sobrecarga sensorial.
-  Agresividad reactiva.
-  A mayor funcionalidad/adolescencia: más necesidad de interacción, más respuesta emocional.

- ToM
- Función ejecutiva
- Coherencia Central



Escalas

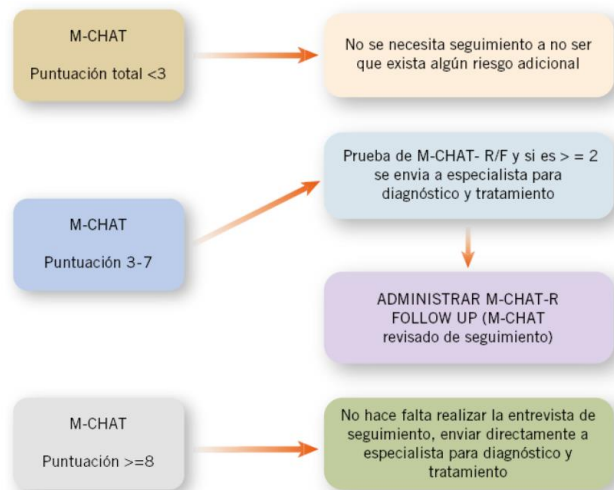


Figura 1. Algoritmo recomendado basado en M-CHAT R/F. screening en dos fases.
Fuente: Robins DL, Casagrande K, Barton M, et al. Validation of Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised With Follow-up (M-CHAT-R/F). Pediatrics. January 2014; 133: 1.

Dimensiones	Escala	Puntuación
Dimensión social		1+2+3
1.-Trastorno de la relación social		
2.-Trastorno de la referencia conjunta		
3.-Trastorno intersubjetivo y mentalista		
Dimensión de la comunicación y el lenguaje		4+5+6
4.-Trastorno de las funciones comunicativas		
5.-Trastorno del lenguaje expresivo		
6.-Trastorno del lenguaje receptivo		
Dimensión de la anticipación/flexibilidad		7+8+9
7.-Trastorno de la anticipación		
8.-Trastorno de la flexibilidad		
9.-Trastorno del sentido de la actividad		
Dimensión de la simbolización		10+11+12
10.-Trastorno de la ficción		
11.-Trastorno de la imitación		
12.-Trastorno de la suspensión		
Puntuación total en el espectro autista		

C.A.R.S. (Childhood autism rating scale)			
Puntuación >30			
I	Relación con la gente	VIII	Respuesta Auditiva
II	Imitación	IX	Uso y rta del gusto, olfato y tacto
III	Respuesta emocional	X	Miedo o Nerviosismo
IV	Uso del cuerpo	XI	Comunicación Verbal
V	Uso del objeto	XII	Comunicación no verbal
VI	Adaptación al cambio	XIII	Nivel de actividad
VII	Respuesta Visual	XIV	Nivel y consistencia de la rta emocional

Diferencial

TEA

- “Asperger” TEA I:
 - Desarrollo del lenguaje Normal, cualitativamente diferente.
 - Inteligencia normal o superior.
- “Atípico” TEA II :
 - Hay lenguaje, pero alteraciones cualitativas en los mismos aspectos.
- “Típico o tipo Kanner” TEA III
 - Mayor afectación.

Otros

- Disfasia.
- Tx. Pragmático del lenguaje
- Tx. De Integración sensorial.
- Deficiencias sensoriales.
- Negligencia o maltrato/abuso.
- Tx de aprendizaje no verbal.
- Ansiedad social.
- Tx de la personalidad.

Tabla I. Criterios de los trastornos del espectro autista del DSM 5

Trastorno del espectro autista

A. Deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social que se presentan en diferentes contextos, ya sea actualmente o en el pasado:

- Deficiencias de reciprocidad socioemocional, que puede presentarse desde aproximaciones sociales anormales y fracaso para mantener una conversación bidireccional, a una disminución para compartir intereses o emociones, hasta una falta total en la iniciación de la interacción social
- Graves dificultades en la comunicación no verbal que se hacen presentes en la interacción social; la presentación va desde una baja integración de la comunicación verbal y no verbal, manifestada con el contacto ocular y el lenguaje corporal, a déficits en la comprensión y uso de la comunicación no verbal, hasta una completa falta de expresión facial y gestual
- Interferencia para desarrollar y mantener relaciones sociales adecuadas al nivel de desarrollo (aparte de con los cuidadores); la presentación va desde dificultades para ajustar la conducta social a diferentes contextos, dadas las dificultades para compartir juego imaginativo y para hacer amistades, hasta una falta aparente de interés en las personas

B. Presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, tal como se manifiesta en dos o más de los siguientes puntos:

- Comportamientos motores, verbales o uso de objetos de forma estereotipada y repetitiva (como una estereotipia motora simple, uso de objetos de forma repetitiva o frases idiosincrásicas)
- Adhesión excesiva a las rutinas, patrones de comportamiento ritualizados de tipo verbal o no verbal o excesiva resistencia al cambio (como rituales motores, insistencia en una misma ruta o comida, preguntas repetitivas o angustia extrema por pequeños cambios)
- Intereses excesivamente fijos y restringidos que son anormales, ya sea en su intensidad u objeto (como una fuerte vinculación o preocupación por objetos inusuales, excesivamente circunscritos o intereses perseverantes)
- Híper o hiporreactividad sensorial o interés sensorial inusual por aspectos del entorno (como aparente indiferencia al dolor/calor/frío, respuesta negativa a sonidos específicos o texturas, oler o tocar excesivamente los objetos, fascinación por las luces o por dar vueltas a los objetos)

C. Los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas capacidades

D. El conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día

Fuente: American Psychiatric Association, 2014.